Ley que establece la validación clínica y la vigilancia posterior a la implementación de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la atención de salud

Exige que el software con IA de uso diagnóstico, pronóstico o terapéutico se registre como dispositivo médico, acredite validación clínica con población peruana o equivalente y sea objeto de vigilancia de desempeño y de sesgos tras su implementación.

Comisión (Cámara de Diputados): Salud (+ Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital) · **Revisora (Senado):** En asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital · **Prioridad:** media · **Costo fiscal:** bajo · **Plazo:** mediano
Plan Perú 2050: Salud, Inteligencia Artificial

I. Exposición de motivos

El Reglamento de la Ley 31814 califica como de riesgo alto los sistemas de IA que condicionan el acceso a servicios de salud (art. 24.1) y exige evaluación de impacto a las entidades públicas, pero no regula la validez clínica de los algoritmos ni su seguimiento una vez en uso. La Ley 29459 regula los dispositivos médicos y su registro sanitario ante la autoridad nacional, pero fue diseñada para productos físicos y no contempla expresamente el software que aprende o se actualiza, ni la degradación de desempeño cuando el algoritmo se aplica a poblaciones distintas de aquellas con las que fue entrenado. Esto es especialmente relevante en el Perú por su diversidad étnica, geográfica (altura) y epidemiológica: un algoritmo validado en otros países puede tener menor exactitud en pacientes peruanos sin que nadie lo detecte. La Organización Mundial de la Salud, en su guía sobre ética y gobernanza de la IA para la salud (2021), recomienda validación en el contexto de uso, transparencia y vigilancia continua. Esta propuesta aborda solo la gobernanza de los algoritmos clínicos; la telesalud y la historia clínica electrónica corresponden a otro eje.

II. Fórmula legal

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE ESTABLECE LA VALIDACIÓN CLÍNICA Y LA VIGILANCIA POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE SALUD

Artículo 1. Objeto

La presente ley tiene por objeto garantizar la seguridad, eficacia y equidad de los sistemas de inteligencia artificial utilizados en la atención de salud, mediante su validación clínica, registro y vigilancia posterior a la implementación.

Artículo 2. Ámbito

La presente ley se aplica a los sistemas de inteligencia artificial destinados a apoyar el diagnóstico, pronóstico, triaje, selección de tratamiento o monitoreo de pacientes, utilizados por establecimientos de salud públicos, privados o mixtos. No comprende los sistemas de uso exclusivamente administrativo.

Artículo 3. Incorporación del artículo 4-A a la Ley 29459

Incorpórase el artículo 4-A a la Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, con el texto siguiente:
«Artículo 4-A. Programas informáticos como dispositivos médicos
Se consideran dispositivos médicos los programas informáticos, incluidos los basados en inteligencia artificial, destinados por su fabricante a fines de diagnóstico, prevención, seguimiento, pronóstico o tratamiento de enfermedades, conforme a la clasificación de riesgo que establezca el reglamento.»

Artículo 4. Validación clínica

4.1. El registro sanitario de un sistema de IA de uso clínico requiere evidencia de validación clínica que incluya datos de desempeño desagregados por sexo, grupo etario y, cuando sea pertinente, por ámbito geográfico o

condición de altitud.
4.2. Cuando la validación se haya realizado fuera del país, la autoridad puede exigir un estudio de validación local o un periodo de uso supervisado antes de su uso generalizado, conforme a la clase de riesgo.

Artículo 5. Vigilancia posterior a la implementación

5.1. El titular del registro sanitario y el establecimiento usuario reportan a la autoridad nacional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios los incidentes adversos, errores sistemáticos y la degradación significativa del desempeño del sistema.
5.2. Las actualizaciones del algoritmo que modifiquen su finalidad o su desempeño clínico se comunican antes de su despliegue, conforme a un plan de cambios predeterminado aprobado con el registro.

Artículo 6. Supervisión profesional

Las decisiones clínicas apoyadas por sistemas de IA son adoptadas bajo responsabilidad del profesional de la salud tratante, quien puede apartarse de la recomendación del sistema dejando constancia en la historia clínica. El paciente tiene derecho a ser informado del uso de dichos sistemas en su atención.

Artículo 7. Registro público de sistemas autorizados

La autoridad nacional de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios publica en formato abierto la relación de sistemas de IA de uso clínico con registro sanitario vigente, su clase de riesgo, indicación aprobada y resumen de la evidencia de validación.

Artículo 8. Datos para validación

El Ministerio de Salud promueve conjuntos de datos clínicos anonimizados de referencia, con representatividad nacional, para la validación independiente de sistemas de IA, conforme a la Ley 29733 y a las reglas de anonimización vigentes.

Primera. Disposición Complementaria Final

Reglamentación. El Ministerio de Salud adecúa el reglamento de dispositivos médicos en un plazo de ciento ochenta días hábiles, tomando como referencia los documentos del International Medical Device Regulators Forum sobre software como dispositivo médico.

Segunda. Disposición Complementaria Final

Adecuación. Los sistemas en uso a la entrada en vigencia del reglamento se adecúan en un plazo de dos años.

Tercera. Disposición Complementaria Final

Financiamiento. La implementación se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud y con los derechos de tramitación correspondientes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cuarta. Disposición Complementaria Final

Vigencia. La presente ley entra en vigencia al día siguiente de la publicación de su reglamento.

III. Análisis costo-beneficio

Genera costos para la autoridad sanitaria (capacidades de evaluación de software) y para los fabricantes (estudios de validación), parcialmente cubiertos por derechos de tramitación. Puede retrasar la entrada de algunos productos, lo que se mitiga con la vía de uso supervisado. El beneficio es la prevención de errores diagnósticos sistemáticos que afectan a muchos pacientes a la vez, la detección de sesgos contra grupos subrepresentados y la confianza de profesionales y pacientes, condición para una adopción sostenible de la IA en salud. No genera gasto adicional al Tesoro.

IV. Efecto de la vigencia de la norma

Modifica la Ley 29459 (incorpora el art. 4-A); complementa la Ley 31814 y su Reglamento. La numeración del artículo incorporado debe verificarse contra el texto vigente de la Ley 29459.

V. Indicador de éxito al 2031

Al 2031, registro público de sistemas de IA de uso clínico operativo, con 100% de los sistemas usados en establecimientos públicos registrados y con reporte anual de vigilancia de desempeño.

Normas relacionadas

• Ley 29459, Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29459.pdf

• Decreto Supremo 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley 31814 (art. 24.1, riesgo alto en salud) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

• Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales — https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29733.pdf

Antecedentes

Por verificar en SPLEY.

Referencias internacionales

• Global: OMS, Ethics and governance of artificial intelligence for health (2021) — https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

• Unión Europea: Reglamento (UE) 2024/1689, art. 6 y Anexo I (sistemas de alto riesgo que son productos sanitarios) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

• OCDE: Recomendación del Consejo sobre Inteligencia Artificial — https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449

Fuentes

• OMS, Ethics and governance of AI for health — https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200

• Reglamento de la Ley 31814 (D.S. 115-2025-PCM) — https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2436426-1

Propuesta ciudadana de libre uso — no es un proyecto presentado. Versión web: https://unimauro.github.io/agenda-legislativa-tech/p/IA-08.html